

Répétitoire finalistes 2011

Dépendances

15 juin, 11h00-12h00

Prof. J. Besson

Une patiente de 32 ans vous consulte en raison d'une consommation régulière d'héroïne qu'elle n'arrive plus à contrôler. Elle a débuté cette consommation il y a deux ans dans le contexte d'une rupture sentimentale. Elle a également des antécédents d'abus de diverses substances dans l'adolescence et elle vit actuellement dans une situation socio-professionnelle précaire. Vous constatez qu'elle a des traces d'injections sur les avant-bras. Une prise d'urine se révèle positive pour la présence d'opiacés. Elle vous indique qu'elle doit s'occuper tous les jours de deux chiens qui lui ont été confiés par une amie, et elle tient beaucoup à cette tâche. Que proposez-vous à cette patiente?

- A. Une inscription au groupe local des Narcotiques Anonymes
- B. Une hospitalisation en milieu somatique pour prise en charge des sites d'injection et bilan pour HIV et hépatites virales
-  C. L'introduction d'un traitement de substitution à la méthadone associée à une prise en charge médico-psycho-sociale
- D. Une psychothérapie intensive à raison de 2 à 3 séances par semaine
- E. Un séjour hospitalier dans une clinique spécialisée pour sevrage d'opiacés

(Besson)

Un étudiant de 22 ans vous consulte parce qu'il est très anxieux de rater ses examens à l'Université dans 3 mois. Il vous demande une prescription d'un médicament « efficace » pour enlever ses angoisses et il vous indique qu'il consomme actuellement 3 à 4 joints de cannabis par jour pour se calmer. Cette consommation de cannabis ne lui pose pas de problèmes – selon ses dires – mais il vous avoue quand même que cette consommation contribue à perturber son rythme circadien (il se couche souvent très tard et n'arrive pas à se rendre aux cours le lendemain). Qu'envisagez-vous pour aider ce patient?

- A. Vous proposez la prescription d'un traitement de benzodiazépines
- ☒ B. Vous optez pour l'organisation d'un entretien avec tous les membres de sa famille (parents, frères et sœurs)
- C. Vous proposez la prescription d'un traitement antidépresseur
- D. Vous jouez le rôle d'un « parent autoritaire » en lui expliquant qu'il a intérêt d'arrêter la consommation de cannabis parce qu'il risque de rater ses études et, ultérieurement, toute sa vie.

(Besson)

Attention, il manque une 5^e possibilité (fausse)

Une femme de 43 ans, aide-soignante dans un EMS, prend de l'héroïne en fumée depuis un an et abuse d'alcool, pour « tenir le coup ». Elle s'occupe seule à la maison de deux adolescents difficiles. Comme médecin-traitant:

- A. vous la dénoncez au Médecin cantonal en raison des dangers liés à sa profession
- B. vous lui proposez une hospitalisation pour un sevrage
- C. vous lui proposez un traitement pharmacologique pour les troubles anxieux
-  vous installez un traitement de substitution avec de la méthadone et vous surveillez le problème d'alcool ambulatoirement
- E. vous lui proposez de fréquenter les groupes de Narcotiques Anonymes et des Alcooliques Anonymes

(Besson)

Un jeune homme de 25 ans, à l'aide sociale, « zone » et abuse depuis plusieurs mois de Dormicum® (midazolam), qui exacerbe ses troubles du comportement, présents par ailleurs depuis son adolescence. Il vous consulte pour demander une prescription de Dormicum®, car il ne se sent pas bien s'il n'en prend pas, mais il souhaite arrêter. Votre attitude:

- A. vous refusez la prescription et vous lui donnez l'adresse d'un centre spécialisé dans les addictions
- B. vous lui proposez une prescription contrôlée à votre cabinet
-  C. vous lui proposez une prescription de substitution avec une benzodiazépine à longue demi-vie et organisez un sevrage ambulatoirement
- D. vous investiguez le probable trouble de la personnalité sous-jacent
- E. vous prescrivez des antidépresseurs au vu de sa situation psychosociale

(Besson)

Parmi les agents pharmacologiques de la liste ci-dessous, lequel **ne fait pas** partie des agents susceptibles de diminuer l'envie de consommer des drogues (addictolytiques)?

- A. Acamprosate
- ☒ B. Quetiapine
- C. Topiramate
- D. Modafinil
- E. Baclofène

(Besson)

Un jeune schizophrène de 20 ans a déjà présenté plusieurs épisodes psychotiques aigus. Il consomme du cannabis régulièrement depuis l'âge de 13 ans. Comment faut-il comprendre chez lui les rapports entre psychose et cannabis du point de vue étiologique?

- A. Le cannabis provoque la psychose
 - B. La psychose incite à consommer du cannabis
 - C. Psychose et cannabis sont dans un rapport indépendant
 - D. Il y a un facteur commun
-  Le cannabis abaisse le seuil d'expression de la psychose

(Besson)

NB: je ne serais pour ma part pas aussi affirmatif... cf. les travaux de Murray pour une réponse + à A si la consommation a commencé très jeune; et l'aspect « antianhédonique » qui pourrait justifier la réponse B.

Un homme de 35 ans présente des troubles de l'humeur cycliques depuis plusieurs années, allant en s'aggravant, avec des consommations épisodiques mais importantes de cocaïne et d'alcool. Le diagnostic le plus probable est:

- ☒ A. trouble bipolaire accompagné pendant les phases maniaques d'abus de cocaïne et d'alcool
- B. trouble bipolaire accompagné pendant les phases dépressives d'abus de cocaïne et d'alcool
- C. abus de cocaïne et d'alcool provoquant des épisodes dépressifs récurrents
- D. épisodes dépressifs récurrents avec automédication à la cocaïne et à l'alcool

(Besson)

Attention: il manque une 5^e réponse fausse

Un jeune homme de 23 ans a passé toute la nuit dans une soirée techno et a consommé de l'alcool et des drogues de synthèse, dont de l'ectasy. Au petit matin, il présente des troubles du comportement, il est irritable et présente des idées de persécution. Votre diagnostic de probabilité aux urgences:

- A. un premier épisode schizophrénique
- B. un delirium alcoolique
- C. une agitation sur déshydratation
- ☒ D. une intoxication aiguë aux amphétamines
- E. une épilepsie partielle complexe

(Besson)

Une femme de 30 ans abuse chroniquement de benzodiazépines et a été suivie par de nombreux médecins, tous mis en échec par les troubles anxieux, l'irritabilité de la patiente, qui a fait plusieurs tentamens et gestes d'automutilation. Quelle est la meilleure attitude pour tenter de la stabiliser et d'améliorer l'alliance thérapeutique?

- A. Lui proposer une hospitalisation pour un sevrage et une investigation des troubles anxieux et de l'humeur
- ☒ B. Lui offrir un traitement de substitution des benzodiazépines avec remise de comprimés à votre cabinet, et investiguer prudemment les troubles anxieux à la recherche d'un état de stress post-traumatique
- C. Lui conseiller de participer à un groupe d'entraide pour partager son histoire de vie et être accompagnée pour son rétablissement
- D. Initier une pharmacothérapie avec des antidépresseurs, comme traitement de fond des troubles anxieux et de la dépendance aux benzodiazépines
- E. Lui prescrire des antipsychotiques atypiques en raison de son impulsivité

(Besson)

Une femme de 28 ans, SDF, polytoxicomane (cocaïne, héroïne, benzodiazépines) se prostitue et présente des troubles psychiatriques chroniques d'allure psychotique. Elle vous consulte pour demander de l'aide sur pression des Services sociaux de la Ville. Vous proposez:

- A. une hospitalisation d'office en psychiatrie
 - B. vous saisissez la Justice de Paix pour qu'elle ordonne une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance
 - C. vous lui proposez un séjour en résidentiel socio-éducatif spécialisé dans les addictions
 - D. vous lui présentez tout d'abord des antipsychotiques atypiques à petite dose pour stabiliser ses troubles psychotiques
-  vous instaurez un traitement de substitution avec de la méthadone, avec remise quotidienne des doses à votre cabinet, pour créer une alliance thérapeutique

(Besson)

Un homme de 30 ans suit un traitement de substitution avec de la méthadone depuis plusieurs mois chez vous. Récemment, il a trouvé un emploi et s'est remis au travail, comme bûcheron, ce qui le stresse passablement. Depuis quelques jours, il se plaint de nausées, de sudation et d'anxiété. Vous :

-  faites un dosage sanguin de méthadone pour ajuster les doses de méthadone à sa nouvelle situation
- B. investiguez ses difficultés d'adaptation à sa nouvelle place de travail
- C. lui prescrivez des benzodiazépines pour l'aider à gérer passagèrement cette phase d'adaptation
- D. traitez symptomatiquement ses troubles digestifs
- E. installez un traitement antidépresseur pour prévenir les troubles anxieux et l'aider à gérer le stress

(Besson)

Un homme de 38 ans vous consulte dans le cadre de difficultés psychosociales. Il a perdu son emploi, a divorcé, et ne voit qu'occasionnellement ses deux enfants de 10 et 12 ans, dont l'un est suivi au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour des troubles du comportement. Le patient consomme des substances psycho-actives dans des soirées privées le week-end et vous rapporte que la cocaïne l'aide à se concentrer et à se sentir mieux.

- A. Par l'approche motivationnelle, vous lui montrez les désavantages de la cocaïne
-  Vous suspectez chez lui un trouble hyperactif avec déficit de l'attention de l'adulte et vous évoquez une prescription de Ritaline®
- C. Vous lui montrez que la cocaïne est une automédication de sa dépression
- D. Vous investiguez ses déficits cognitifs pour expliquer ses difficultés de concentration
- E. Vous installez un traitement antidépresseur dans le but de stabiliser ses troubles de l'humeur et de pallier ses consommations de cocaïne

(Besson)